今日論文 • 第 04 篇 公開全文

針灸相關療法治療中風後輕度認知障礙：系統回顧與網絡 Meta 分析

Integrative approaches to acupuncture therapies for post-stroke mild cognitive impairment: a systematic review and network meta-analysis

作者 Huang S-L, Hui Y-Y, Zhang W, Tang X, Peng F, Liu Z-Y, Zheng H, Zhai Y

期刊 Frontiers in Neurology（2026年11月2日）

識別碼 DOI 10.3389/fneur.2026.1954073 • PROSPERO CRD420251165945

取用 公開全文

官方連結（點擊即可打開）

- Frontiers 公開全文 https://www.frontiersin.org/journals/neurology/articles/10.3389/fneur.2026.1954073/full
- DOI https://doi.org/10.3389/fneur.2026.1954073

研究是什麼

針對中風後輕度認知障礙（PSMCI）的系統回顧與網絡 Meta 分析，比較多種針灸及針灸聯合療法在 MoCA、MMSE、Barthel 指數及總有效率上的相對效果與安全性，避免把不同程度的中風後認知障礙混為一談。

方法要點

- 檢索九個資料庫及四個試驗註冊平台，截至 2025 年 10 月。納入中、英文 RCT；以 Cochrane RoB 2 評估偏倚，CINeMA／GRADE 評估證據可信度。
- 最終納入 47 項 RCT、3,680 名患者、約 15 類針灸相關介入。幾乎全部研究在中國進行，多數以中文發表。
- 常用穴位頻率較高者包括百會（DU20）、神庭（DU24）、四神聰（EX-HN1）、風池（GB20）、神門（HT7）。

主要結果

- 成對 Meta：針灸聯合常規治療，一般較單一干預更能改善認知。例如電針＋認知訓練改善 MoCA 優於單用認知訓練（5 項 RCT，MD 2.49，95% CI 1.60–3.38）。
- 網絡 Meta（須在相應網絡內解讀）：改善 MoCA 及總有效率，電針＋艾灸排名較前（相對認知訓練，MoCA MD 5.42，95% CI 2.10–8.74；SUCRA 約 94.6%）。
- 改善 MMSE：電針＋高壓氧、毫針＋重複經顱磁刺激較前。改善 Barthel：毫針＋多奈哌齊（MD 8.67，95% CI 5.47–11.88）、電針＋認知訓練較前。
- 13 項研究報告不良事件，多為輕微皮下血腫、暈針、頭暈或惡心，未見嚴重事件組間明顯增加。
- 證據質量參差：47 項中 8 項整體高偏倚風險、10 項低風險、29 項存在疑慮。MoCA 比較的可信度多數為低至中等，僅兩項比較評為高。

中醫診所臨床啟示

- 中風後記憶或認知輕度下降的康復門診，針灸（尤其電針配合艾灸，或針灸配合認知訓練）可作輔助討論，並與神經科、康復科並行。
- SUCRA 排名只供參考，不能當成「最佳方案」；部分網絡互不連通，不同子網絡的排名不可直接對比。

- 須向患者及家屬說明：多數試驗方法學質量有限、幾乎全在中國進行，外推須謹慎；不能取代急性中風或痴呆的標準評估。

限制與解讀注意

- 納入研究偏倚風險高、異質性大，部分比較證據等級很低。
- 幾乎全為中國試驗，外部效度有限；MMSE、Barthel 形成互不連通的子網絡。
- 作者亦指出針刺手法、劑量參數報告不足，影響可重複性。

聲明：這份 PDF 由新聞bot 根據已核實的摘要及（如屬公開取用）論文頁面撰寫中文摘要，方便診所快速閱讀，並非出版社官方譯本，亦不是論文全文。關鍵數據請以官方全文為準。本摘要供專業參考，不能代替個別患者的臨床判斷。